

DANS CE SUJET

+

AUTRES SUJETS DANS CE CHAPITRE

→

Perte brutale de la vision

→

Anisocorie

→

Vision trouble

→

Diplopie

→

Œdème des paupières

→

Douleur oculaire

→

Corps flottants

→

Exophtalmie

→

Œil rouge

→

Larmolement

→

Autres symptômes oculaires

Œdème des paupières



VOIR L'ÉDUCATION DES PATIENTS

Par **Christopher J. Brady**, MD, Larner College of Medicine, University of Vermont
Reviewed By **Sunir J. Garg**, MD, FACS, Thomas Jefferson University

Vérifié/Révisé oct. 2025

Étiologie | Bilan | Traitement | Points clés | Multimédia

Un œdème des paupières peut être unilatéral ou bilatéral. Il peut être asymptomatique ou accompagné par un prurit ou une douleur.

Étiologie du gonflement des paupières

Le gonflement des paupières a de nombreuses causes (voir tableau [Certaines causes d'œdème palpébral](#)). Il est habituellement le résultat d'une atteinte palpébrale mais il peut résulter de maladies situées dans et autour de l'orbite ou de troubles systémiques qui induisent un œdème généralisé.

Les causes **les plus fréquentes** sont allergiques, dont:

- L'allergie locale (hypersensibilité de contact)
- L'allergie systémique (p. ex., un [angio-œdème/œdème de Quincke](#) ou des signes d'allergie systémique accompagnant une [rhinite allergique](#))

Un œdème localisé d'une paupière est le plus souvent cause par un [chalazion](#).

L'inflammation unilatérale ou bilatérale des paupières peut être causée par une blépharite ou une conjonctivite ([1,2](#)).

Les causes les plus immédiatement dangereuses sont la [cellulite orbitaire](#) et la [thrombose du sinus caverneux](#) (rares).

En plus des troubles énumérés dans le tableau [Certaines causes d'œdème palpébral](#), un œdème des paupières peut résulter des causes suivantes:

- Les troubles qui peuvent impliquer la paupière mais ne provoquent pas d'œdème, sauf à un stade très évolué (p. ex., tumeurs palpébrales, dont les carcinomes malpighiens et le mélanome)
- Troubles qui provoquent un œdème qui débute et est habituellement le plus sévère au niveau des structures proches, mais qui ne font pas partie, des paupières (p. ex., [dacryocystite](#), [canaliculite](#))
- Les troubles au cours desquels un œdème survient, mais qui n'est pas le symptôme initial (p. ex., fracture de la base du crâne, brûlures, traumatisme, en post-opératoire)

Références pour l'étiologie

1. [Amescua G, Akpek EK, Farid M, et al.](#) Blepharitis Preferred Practice Pattern®. *Ophthalmology*. 2019;126(1):P56-P93. doi:10.1016/j.ophtha.2018.10.019
2. [Cheung AY, Choi DS, Ahmad S, et al.](#) Conjunctivitis Preferred Practice Pattern. *Ophthalmology*. 2024;131(4):P134-P204. doi:10.1016/j.ophtha.2023.12.037

TABLEAU

[Certaines causes d'œdème palpébral](#)



Évaluation du gonflement des paupières

Anamnèse

L'**anamnèse de la maladie actuelle** doit établir depuis combien de temps l'œdème a été présent, s'il est uni ou bilatéral, et s'il a été précédé par un traumatisme quelconque (y compris des morsures d'insecte). Les symptômes importants à identifier sont le prurit, la douleur, les céphalées, les modifications de la vision, la fièvre et les sécrétions palpébrales.

La **revue des systèmes** doit rechercher des symptômes des causes possibles, y compris un nez qui coule, un prurit, une éruption cutanée et un wheezing (réaction allergique systémique); des céphalées, une congestion nasale et un écoulement nasal purulent ([sinusite](#)); un mal de dents (infection dentaire); des troubles respiratoires, orthopnée et dyspnée paroxystique nocturne ([insuffisance cardiaque](#)); une intolérance au froid et des modifications de texture cutanée ([hypothyroïdie](#)); et une intolérance à la chaleur, de l'anxiété et une perte de poids ([hyperthyroïdie](#)).

La **recherche des antécédents médicaux** doit porter sur une blessure ou une chirurgie oculaire récente; une maladie cardiaque, hépatique, rénale ou thyroïdienne connue; et des allergies ainsi que sur l'exposition à de possibles allergènes. L'anamnèse médicamenteuse doit spécifiquement comprendre la recherche de prise d'inhibiteurs de l'ECA.

Examen clinique

L'examen des constantes vitales doit comprendre la recherche d'une fièvre et d'une tachycardie.

L'inspection de l'œil doit évaluer la localisation et la couleur du gonflement (érythémateux ou pâle), et s'il est présent sur une ou les deux paupières d'un œil ou une ou les deux paupières des deux yeux et s'il est douloureux et/ou chaud. L'examineur doit observer s'il s'agit d'un œdème des paupières et/ou d'une protrusion du globe ([exophtalmie](#)). L'examen oculaire doit particulièrement noter l'acuité visuelle et l'amplitude des mouvements oculaires (complète ou limitée). Cet examen peut être difficile lorsque l'œdème est marqué mais il est important car ces déficits suggèrent une affection orbitaire ou rétro-orbitaire plutôt qu'une affection palpébrale; une aide peut être nécessaire pour maintenir les paupières ouvertes. Les conjonctives sont examinées à la recherche d'une injection et d'un écoulement. Toute lésion des paupières ou du globe est examinée à la lampe à fente.

L'examen général doit rechercher des signes d'intoxication, suggérant une infection grave et les signes d'une maladie causale. La peau du visage est inspectée à la recherche de sécheresse et de squames (qui peuvent suggérer l'hypothyroïdie) et de squames grasseuses ou d'autres signes de la dermite séborrhéique. Les extrémités inférieures et la zone présacrée sont examinées à la recherche d'[œdèmes](#), ce qui suggère une cause systémique. Pour une discussion approfondie de l'évaluation d'une cause systémique, voir [Œdème](#).

Signes d'alarme

Les signes suivants sont particulièrement préoccupants:

- Fièvre
- Perte d'acuité visuelle
- Diminution des mouvements oculaires
- Exophtalmie

Interprétation des signes

Certains signes aident à établir la différence entre catégories de maladies. La première distinction importante est entre une inflammation et une infection ou entre l'allergie et l'excès de liquides. Des douleurs, une rougeur, une chaleur et une sensibilité suggèrent une inflammation ou une infection. L'œdème indolore et pâle suggère un angio-œdème/œdème de Quincke. Le prurit suggère une réaction allergique et l'absence de prurit suggère un dysfonctionnement cardiaque ou rénal.

Un œdème localisé à une paupière sans autres symptômes est rarement dû à une maladie grave. Une tuméfaction massive des paupières de l'un ou des deux yeux doit faire suspecter un trouble sérieux. Des signes d'inflammation, une exophtalmie, une perte visuelle et une limitation des mouvements oculaires évoquent une affection orbitaire (p. ex., [cellulite orbitaire](#), [thrombose du sinus caverneux](#)) qui peut repousser le globe en avant ou toucher les nerfs ou les muscles. D'autres signes évocateurs et spécifiques sont listés dans le tableau [Certaines causes d'œdème palpébral](#).

Examens complémentaires

Dans la plupart des cas, un diagnostic peut être établi cliniquement et aucun examen complémentaire n'est nécessaire. Si une [cellulite orbitaire](#) ou une [thrombose du sinus caverneux](#) est suspectée, diagnostic et traitement doivent être effectués le plus rapidement possible. Une imagerie par TDM ou IRM doit être obtenue immédiatement. Si une affection cardiaque, hépatique, rénale ou thyroïdienne est suspectée, la fonction de ces organes est évaluée avec les examens de laboratoire et l'imagerie appropriés.

Traitement du gonflement des paupières

Le traitement est celui du trouble sous-jacent. Il n'y a pas de traitement spécifique de l'œdème.

Points clés

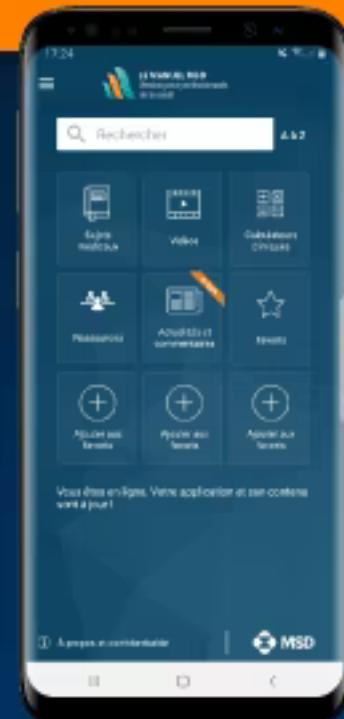
- Une exophtalmie avec baisse de la vision ou limitation des mouvements oculaires fait évoquer une cellulite orbitaire ou une thrombose du sinus caverneux et le diagnostic et le traitement doivent être réalisés le plus rapidement possible.
- Les lésions des paupières doivent être différenciées des causes orbitaires et systémiques d'œdème.



TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Take a Quiz!

Téléchargez gratuitement l'application Manuels MSD



Scannez le code pour télécharger dès maintenant

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

